

| RECAPITULATIVO DE METODOLOGIA · MÓDULOS M5 + M6

Estimativas de cobertura

O que os módulos fazem · Como ler o resultado

O QUE FAZEM

Transformam contagens de serviços em bruto em **cobertura** — a proporção das pessoas que *precisavam* de um serviço e que efetivamente o receberam.

DUAS PARTES

M5 calcula a **população-alvo** (a parte difícil)

M6 transforma-a em cobertura e preenche os anos entre inquéritos

TENHA PRESENTE

Estas são **estimativas a partir de dados de rotina** — boas para tendências e comparação, não números nacionais oficiais.

O que significa «cobertura»

A cobertura responde a uma pergunta simples: **de todas as pessoas que precisavam de um serviço, que proporção o recebeu?**

Tome as primeiras visitas pré-natais (CPN1). Se **10 000** mulheres estavam grávidas num distrito e **8 000** delas tiveram uma visita de CPN1, então a cobertura é $8\,000 \div 10\,000 = 80\%$.

Por isso a cobertura é sempre uma fração:

cobertura = o número atendido ÷ o número que precisava dele

Service coverage =

Population who received the service

Numerator comes from DHIS2 data — service volumes after quality correction

Population who need the service (target population)

Several options for estimating the denominator

O obstáculo

O número **de cima** é fácil — as 8 000 visitas de CPN1 vêm diretamente do HMIS; é apenas a contagem de serviços.

O número **de baixo** é a parte difícil: **ninguém conta quantas mulheres grávidas (ou bebés) há**. Nenhuma unidade entrega um relatório a dizer «houve aqui 10 000 mulheres grávidas este ano».

Por isso toda a tarefa destes módulos se resume a uma pergunta — **onde obtemos esse número de baixo, a população-alvo?** É isso que o M5 se propõe estimar.

| M5 · ESTIMAR A POPULAÇÃO

Como o M5 encontra o número de baixo

Passo 1 — pedi-lo emprestado a um inquérito. De poucos em poucos anos, um inquérito domiciliar mede a cobertura *diretamente*, entrevistando famílias. Pode dizer-nos que, digamos, **80% das mulheres grávidas tiveram CPNI**. Agora combine isto com a contagem que já temos: se as **8 000** visitas de CPNI são 80% de todas as mulheres grávidas, então o total é $8\,000 \div 0,80 = 10\,000$ **mulheres grávidas**. Recuperámos o número de baixo que não conseguíamos contar.

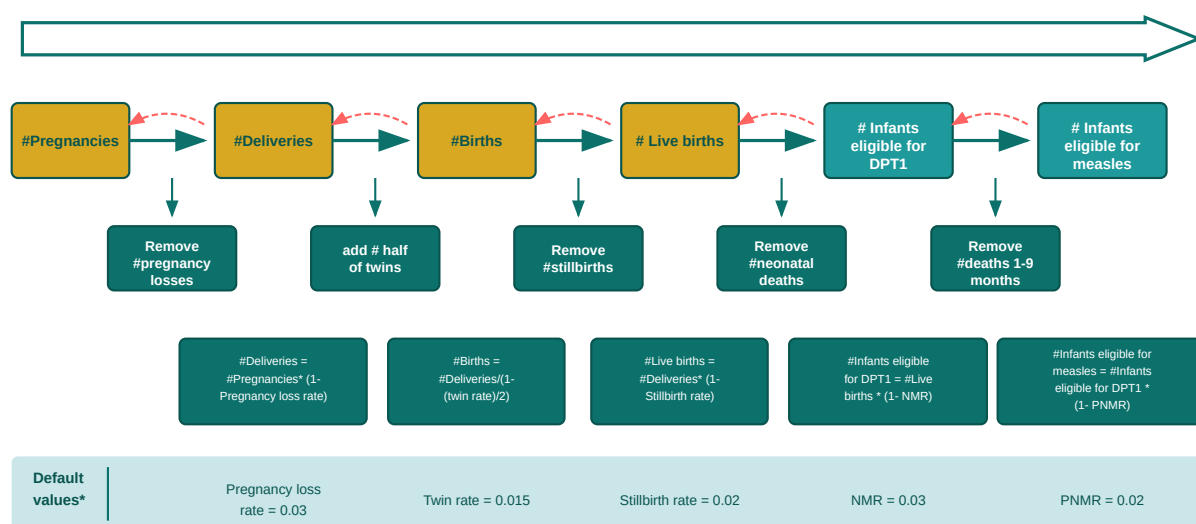
Passo 2 — ajustá-lo ao grupo certo. 10 000 mulheres grávidas é o denominador certo para os cuidados pré-natais — mas a **Pental é dada a bebés**, um grupo diferente. Não precisamos de um segundo inquérito: uma gravidez *torna-se* um nascimento *torna-se* um bebé, e sabemos aproximadamente quantos se perdem em cada etapa. Por isso o FASTR vai descendo o número — menos abortos espontâneos e nados-mortos, menos mortes neonatais — até cerca de **9 100 bebés**. Um inquérito dá agora o denominador para *todos* os indicadores.

Passo 3 — verificação cruzada, e escolher o melhor. A CPNI não é o único ponto de partida; partos, Pental e BCG dão cada um a sua própria estimativa da população, e não vão todos concordar. Para escolher, o FASTR alinha cada estimativa com a **projeção populacional da ONU** — um valor independente construído sem o HMIS — e mantém a que fica mais próxima.

A cobertura só é tão boa quanto o seu denominador. É por isso que o M5 não confia num único indicador — triangula vários e deixa a projeção independente da ONU desempatar.

M5 · A CADEIA DA VIDA (PASSO 2)

De gravidezes a bebés



*FASTR approach uses country-specific values for stillbirth rate, NMR, PNMR, and IMR if they are available from DHS/MICS

As **setas verdes** avançam — cada uma aplica uma taxa demográfica padrão (subtraindo as perdas dessa etapa). As **setas vermelhas correm para trás**: as mesmas taxas permitem **retrocalcular** a cadeia a partir de qualquer ponto, por isso o FASTR pode começar pelo indicador que tiver um inquérito (CPN1, parto, Pental...) e ainda assim chegar a todas as outras populações-alvo.

M6 · O RESULTADO

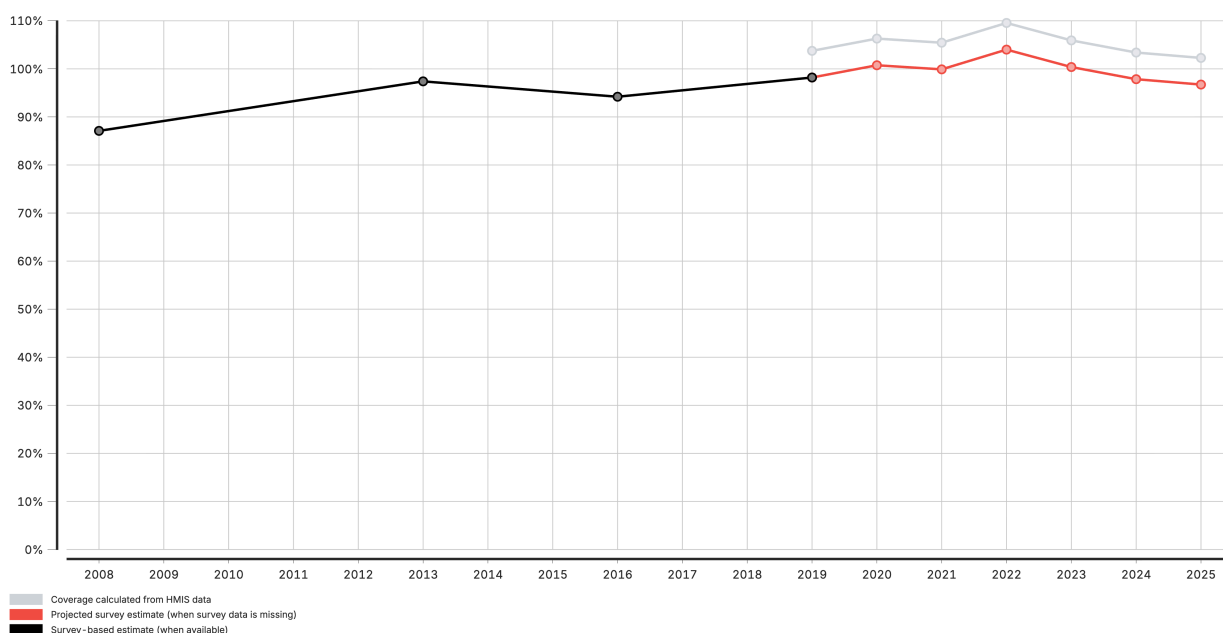
Cobertura ao longo do tempo

Agora a parte fácil: **cobertura = contagem HMIS ÷ essa população**, para cada indicador, ano e área. Os inquéritos só acontecem de poucos em poucos anos, por isso entre eles o FASTR mantém o último valor do inquérito e desloca-o por quanto a cobertura HMIS se moveu — o inquérito define o nível, o HMIS a direção.

Coverage estimates for Antenatal client 1st visit

2008 to 2025

DISCLAIMER: These results use routine data to provide rigorous, but not official estimates. They should be interpreted considering any data quality or representation limitations, including data quality findings and any other country specific factors.



Estimating service coverage from administrative data can provide more timely information on coverage trends, or highlight data quality concerns. Numerators are the volumes reported in HMIS, adjusted for data quality. Denominators are selected from UN projections, survey estimates, or derived from HMIS volume for related indicators. National projections are made by applying HMIS trends to the most recent survey data. Subnational estimates are more sensitive to poor data quality, and projections from surveys are not calculated.

MICS data courtesy of UNICEF. Multiple Indicator Cluster Surveys (various rounds) New York City, New York.

DHS data courtesy of ICF. Demographic and Health Surveys (various rounds). Rockville, Maryland.

Data for the current year reflect the period available at the time of analysis; population figures have been scaled to match the corresponding duration.

- **As linhas — cinzento** = cobertura HMIS (contagem ÷ população estimada), todos os anos, rotulada *Dados administrativos* na plataforma; **preto** = resultados reais de inquérito (MICS/DHS), rotulados *Estimativa baseada em inquéritos*; **vermelho** = o nível de inquérito projetado para a frente sobre a tendência HMIS onde não existe inquérito, rotulado *Estimativa projetada*
- **Como ler** — onde a linha cinzenta do HMIS e os pontos pretos do inquérito ficam próximos, o denominador é sólido e a tendência é fiável; depois leia a direção — a subir, plana ou a escorregar
- **Atenção a** — cobertura **acima de 100%** é um sinal de aviso (denominador demasiado baixo ou contagem inflacionada), não cobertura real acima do total

O mesmo gráfico é produzido a nível nacional, regional e distrital — leia-os em conjunto: